

ORL · OPHTALMOLOGIE · STOMATOLOGIE & CHIR. MAXILLO-FACIALE

Fiches QE Haute Fréquence — Module S9 (FMPM) — Version 1

Cross-match : 700 QEs officielles (2017→2026) × Cours AIO (ORL 419 p · Ophtalmo 424 p · Maxillo 330 p)
FMPM — 14 sessions officielles · Janvier 2017 → Normal 2026

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 700 QEs (14 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	TRAUMATISME DU GLOBE OCULAIRE	85 Q	Ophtalmologie
2	TRAUMATISMES DE LA FACE	84 Q	Chir. maxillo-faciale
3	APPAREIL OTOLOGIQUE (OTITES & SURDITÉS)	68 Q	ORL
4	CANCERS ORL (LARYNX · CAVUM · VADS)	56 Q	ORL
5	PARALYSIE FACIALE PÉRIPHÉRIQUE	50 Q	ORL
6	GLAUCOMES	47 Q	Ophtalmologie
7	CAT : ADÉNOPATHIE CERVICALE & NODULE THYROÏDIEN	45 Q	ORL
8	CANCÉROLOGIE MAXILLO-FACIALE	45 Q	Chir. maxillo-faciale
9	INFECTIONS RHINO-PHARYNGO-LARYNGÉES	43 Q	ORL
10	ŒIL ROUGE	43 Q	Ophtalmologie
11	CELLULITES CERVICO-FACIALES D'ORIGINE DENTAIRE	40 Q	Chir. maxillo-faciale
12	CATARACTES	26 Q	Ophtalmologie
13	LIMITATION DE L'OUVERTURE BUCCALE	25 Q	Chir. maxillo-faciale
14	RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE	23 Q	Ophtalmologie
15	GREFFE DE CORNÉE (KÉRATOPLASTIE)	7 Q	Ophtalmologie
16	RÉTINOBLASTOME	7 Q	Ophtalmologie
17	TROUBLES DE LA RÉFRACTION	5 Q	Ophtalmologie
18	QUESTIONS INCLASSIFIABLES	1 Q	—

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 14 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moylexam	% d'exam
TRAUMATISME DU GLOBE OCULAIRE	85	6.07	12.1%
TRAUMATISMES DE LA FACE	84	6.00	12.0%
APPAREIL OTOLOGIQUE (OTITES & SURDITÉS)	68	4.86	9.7%
CANCERS ORL (LARYNX · CAVUM · VADS)	56	4.00	8.0%
PARALYSIE FACIALE PÉRIPHÉRIQUE	50	3.57	7.1%
GLAUCOMES	47	3.36	6.7%
CAT : ADÉNOPATHIE CERVICALE & NODULE THYROÏDIEN	45	3.21	6.4%
CANCÉROLOGIE MAXILLO-FACIALE	45	3.21	6.4%
INFECTIONS RHINO-PHARYNGO-LARYNGÉES	43	3.07	6.1%
ŒIL ROUGE	43	3.07	6.1%
CELLULITES CERVICO-FACIALES D'ORIGINE DENTAIRE	40	2.86	5.7%
CATARACTES	26	1.86	3.7%
LIMITATION DE L'OUVERTURE BUCCALE	25	1.79	3.6%
RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE	23	1.64	3.3%
GREFFE DE CORNÉE (KÉRATOPLASTIE)	7	0.50	1.0%
RÉTINOBLASTOME	7	0.50	1.0%
TROUBLES DE LA RÉFRACTION	5	0.36	0.7%
QUESTIONS INCLASSIFIABLES	1	0.07	0.1%
TOTAL des 18 leçons officielles	700 Q	50.0	100%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] TRAUMATISME DU GLOBE OCULAIRE

Ophtalmologie • ~6.07 Q/examen • 85 Q sur 14 sessions

□ Brûlures oculaires : classification de Roper-Hall

Anatomie cornéenne (de la surface vers la profondeur)

- 5 couches : épithélium → membrane de Bowman → stroma → membrane de Descemet → endothélium
- L'endothélium a une cellularité FIXE (non renouvelable) ; couplé à la Descemet il assure la déturgescence (transparence) cornéenne
- Δ les cellules ganglionnaires sont RÉTINIENNES, PAS cornéennes
- Δ « la cornée contient des vaisseaux » est FAUX : la cornée saine est avasculaire

□ Vu : Jan2017 Q35, Jan2018 Q35, Jan2020 Q46, Jan2021 Q46, Jan2021 Q48, Jan2021 Q50, Jan2022 Q47 ... (+17) (24×)

Contusion du globe — complications possibles

- Segment ANTÉRIEUR : hyphéma, mydriase traumatique, cataracte contusive, iridodonsis (subluxation du cristallin), hémorragie sous-conjonctivale
- Segment POSTÉRIEUR : œdème de Berlin, décollement de rétine, trou/atrophie maculaire, décollement choroïdien, neuropathie optique
- Pression : glaucome post-traumatique (HTO)
- Δ la kératite herpétique n'est PAS une complication de contusion
- Δ « la contusion ne touche jamais le segment postérieur » est FAUX : œdème de Berlin, DR, atteinte maculaire sont possibles
- Δ œil le plus fragile après contusion = fort MYOPE ou œil déjà OPÉRÉ — PAS rétinopathie diabétique / ptérygion / cataracte

□ Vu : Juin2024 Q14, Juin2024 Q17, Nx2025 Q28, Nx2025 Q31, Nx2026 Q32, Nx2026 Q33 (6×)

Hyphéma (sang dans la chambre antérieure)

- Mesurer le tonus oculaire ; repos + boissons abondantes ; hypotonisant SI hypertonie
- Échographie B si fond d'œil inaccessible (pour éliminer une lésion postérieure)
- Δ drainage / lavage chirurgical PAS systématique (réservé aux formes compliquées : HTO rebelle, hématoconée)

□ Vu : Jan2020 Q45, Jan2020 Q48, Jan2021 Q45, Jan2022 Q48, Jan2023 Q33, Jan2023 Q34, Jan2023 Q36 ... (+6) (13×)

Plaie du globe (rupture / perforation) — signes

- HYPOTONIE = signe majeur (mais un TO normal ou élevé NE l'élimine PAS)
- Hernie / incarceration de l'iris, déformation pupillaire, trajet irien
- Seidel POSITIF = fuite d'humeur aqueuse (plaie cornéenne) ; chémosis hémorragique dense = plaie sclérale
- Athalamie / hypothalamie (chambre antérieure plate), corps étranger intra-oculaire (CEIO)
- Δ le strabisme et la mydriase traumatique ne sont PAS des signes de plaie du globe

□ Vu : Jan2017 Q31, Jan2017 Q33, Jan2017 Q35, Jan2021 Q46, Jan2021 Q47, Jan2021 Q48, Jan2021 Q49 ... (+23) (30×)

Plaie du globe — conduite à tenir

- Hospitalisation, patient À JEUN (chirurgie en urgence), statut antitétanique à jour (SAT/VAT)
- Coque rigide protectrice ; NE PAS comprimer le globe
- Imagerie (TDM / écho) si suspicion de CEIO ; parage + suture en urgence
- Δ NE PAS mesurer la pression intra-oculaire (risque d'extrusion du contenu)
- Δ ne jamais appliquer de pansement compressif sur un globe ouvert

□ Vu : Jan2017 Q31, Jan2017 Q33, Jan2017 Q35, Jan2020 Q45, Jan2021 Q45, Jan2021 Q46, Jan2021 Q47 ... (+31) (38×)

Corps étranger intra-oculaire (CEIO)

- Souvent métallique : FER → sidérose ; CUIVRE → chalcose
- Extraction par vitrectomie en urgence ; pronostic souvent réservé
- Peut se compliquer d'endophtalmie
- **⚠ un CEIO métallique ne doit pas être laissé en place « pour surveillance »**

□ Vu : Jan2017 Q33, Jan2018 Q34, Jan2020 Q50, Jan2021 Q47, Juin2023 Q13, Juin2023 Q15, Juin2023 Q16 ... (+12) (19×)

Endophtalmie post-traumatique / post-opératoire

- Suspecter devant une douleur INSOMNIANTE + hypopion après plaie ou chirurgie
- URGENCE thérapeutique : INJECTIONS INTRA-VITRÉENNES d'antibiotiques +++ ± vitrectomie ; ablation d'un CEIO
- Facteurs de risque : plaie pénétrante, CEIO, masses cristalliniennes en chambre antérieure, retard de consultation
- **⚠ antibiotiques par voie générale (IV / per os) ou collyres SEULS sont insuffisants : l'IVT est indispensable**

□ Vu : Jan2017 Q32, Jan2017 Q33, Jan2017 Q34, Juin2023 Q14, Juin2023 Q15, Juin2023 Q17, Juin2024 Q17 ... (+8) (15×)

Brûlures oculaires — gravité et CAT

- Les brûlures par BASE (alcalines) sont PLUS GRAVES que par acide (pénétration profonde, lésions évolutives)
- Geste le PLUS important = LAVAGE abondant immédiat, débuté SUR LES LIEUX (sérum physiologique ou eau)
- Éverser les paupières + retirer les particules ; gravité jugée sur l'atteinte LIMBIQUE (++ pronostique) — classification de Roper-Hall
- **⚠ « l'acide est plus grave que la base » est FAUX (piège classique)**
- **⚠ la NEUTRALISATION n'est PAS le premier geste ; les corticoïdes ne se donnent JAMAIS d'emblée avant lavage**
- **⚠ ne pas différer le lavage en attendant un transfert**

□ Vu : Jan2018 Q32, Jan2018 Q33, Jan2020 Q45, Jan2020 Q50, Jan2021 Q50, Jan2022 Q50, Juin2023 Q15 ... (+14) (21×)

Notions associées (Berlin, ophtalmie sympathique)

- Œdème de Berlin = pâleur du pôle postérieur + macula « rouge cerise » après contusion (≠ OACR)
- Ophtalmie sympathique = baisse de vision du 2^e œil (sain) après plaie perforante de l'œil controlatéral (uvéite auto-immune tardive)
- **⚠ l'ophtalmie sympathique n'est pas immédiate : elle est tardive et bilatéralise l'inflammation**

□ Vu : Jan2017 Q35, Jan2020 Q47, Jan2023 Q35, Juin2023 Q18 (4×)

[RANG 2] TRAUMATISMES DE LA FACE

Chir. maxillo-faciale • ~6.00 Q/examen • 84 Q sur 14 sessions

Fractures de Le Fort (étage moyen)

- Le Fort I = mobilité du MAXILLAIRE seul (fracture horizontale basse)
- Le Fort III = DISJUNCTION CRANIO-FACIALE : mobilité de tout le massif facial p/r au crâne + béance antérieure + hématome « en lunettes »
- **⚠ Le Fort II n'est ni purement maxillaire ni purement cranio-facial : c'est la pyramide naso-maxillaire (intermédiaire)**

□ Vu : Jan2020 Q22, Jan2021 Q20, Jan2022 Q19, Jan2023 Q40, Juin2023 Q40, Jan2024 Q39, Juin2024 Q38 ... (+5) (12×)

Fractures de la mandibule — séméiologie topographique

- Branche HORIZONTALE → hypoesthésie labio-mentonnaire (V3, nerf alvéolaire inférieur)
- Parasymphise → décalage de l'arcade dentaire ; Angle → atteinte V3 + limitation de l'ouverture buccale
- Portion DENTÉE = risque INFECTIEUX (foyer ouvert dans la cavité buccale)
- **⚠ une fracture de la portion non dentée n'a pas le même risque septique que la portion dentée**

□ Vu : Jan2017 Q38, Jan2017 Q40, Jan2017 Q41, Jan2018 Q36, Jan2018 Q38, Jan2020 Q20, Jan2020 Q23 ... (+34) (41×)

Fracture du condyle chez l'ENFANT

- Risque évolutif majeur = ANKYLOSE temporo-mandibulaire + dysmorphose mandibulo-faciale (trouble de croissance)
- ⚠ chez l'enfant le risque n'est PAS la pseudarthrose / la névralgie / l'ostéite, mais l'ankylose

□ Vu : Jan2017 Q41, Jan2018 Q38, Jan2020 Q26, Jan2022 Q18, Jan2022 Q20, Jan2023 Q44, Juin2023 Q44 ... (+8) (15×)

Fracture du plancher de l'orbite (blow-out)

- DIPLOPIE (incarcération du droit inférieur) + hypoesthésie V2 + énophtalmie + hémorragie sous-conjonctivale
- ⚠ pas d'otorragie / rhinorrhée / trouble de l'articulé dentaire ; le rebord orbitaire SUPÉRIEUR n'est pas concerné

□ Vu : Jan2017 Q39, Jan2017 Q40, Jan2020 Q24, Jan2020 Q25, Jan2021 Q21, Jan2022 Q21, Jan2022 Q22 ... (+15) (22×)

Fracture du malaire / zygomatique

- Affaissement de la pommette + hypoesthésie sous-orbitaire (V2) + hémorragie sous-conjonctivale ± limitation d'ouverture buccale
- ⚠ le blocage maxillo-mandibulaire (BMM) ne traite PAS le malaire (cf. mandibule)

□ Vu : Jan2017 Q40, Jan2018 Q37, Jan2020 Q20, Jan2020 Q25, Jan2021 Q23, Jan2022 Q18, Jan2022 Q22 ... (+12) (19×)

Imagerie du traumatisé facial

- Examen de référence = TDM (scanner) du massif facial (coupes axiales + coronales + 3D)
- ⚠ ni IRM, ni orthopantomogramme seul, ni EMG, ni PET-scan en première intention

□ Vu : Jan2017 Q43, Nx2026 Q43 (2×)

Plaies de la face — règles

- Morsure de chien jugale vue > 24 h → LAVAGE + PARAGE, SANS suture (cicatrisation dirigée)
- Ligne lobule de l'oreille → commissure labiale : structures nobles = nerf FACIAL (VII) + canal de STÉNON (parotidien) + glande parotide
- ⚠ ne jamais suturer d'emblée / reconstruire (lambeau, greffe) une morsure de chien souillée vue tardivement
- ⚠ le canal de WHARTON (submandibulaire) n'est PAS sur cette ligne jugale

□ Vu : Jan2018 Q46, Jan2018 Q47, Jan2020 Q21, Jan2021 Q23, Jan2022 Q25, Jan2023 Q39, Juin2023 Q38 ... (+7) (14×)

Urgences vitales du traumatisme facial

- Les 2 urgences VITALES = HÉMORRAGIE + OBSTRUCTION des voies aériennes / corps étranger intra-buccal
- ⚠ une section du nerf facial n'est PAS une urgence VITALE (c'est une urgence fonctionnelle) — clé officielle parfois discutable sur ce point

□ Vu : Jan2017 Q39, Jan2018 Q37, Jan2018 Q46, Jan2021 Q21, Nx2026 Q42 (5×)

[RANG 3] APPAREIL OTOLOGIQUE (OTITES & SURDITÉS)

ORL • ~4.86 Q/examen • 68 Q sur 14 sessions

Tympanométrie — décision diagnostique (surdité de transmission, tympan normal)

- Courbe PLATE (type B) → otite séro-muqueuse (OSM)
- Pic centré sur 0 + compliance NORMALE → OTOSPONGIOSE (fixation stapédienne, Valsalva +)
- Compliance DIMINUÉE → fixation de la tête du marteau
- Compliance ÉLEVÉE / ample → LUXATION de la chaîne ossiculaire
- ⚠ devant ST à tympan normal + tympanogramme plat, le diagnostic est l'OSM (pas l'otospongiose)

□ Vu : Jan2017 Q4, Jan2017 Q5, Jan2018 Q1, Jan2018 Q6, Jan2020 Q1, Jan2020 Q3, Jan2020 Q8 ... (+22) (29×)

Otospongiose

- Tympan NORMAL, surdité de transmission, Valsalva POSITIVE, Rinne négatif, Weber latéralisé du côté sourd

- À différencier d'une luxation ossiculaire par la tympanométrie + TDM des rochers / oreille moyenne
- **⚠ PEA et IRM ne sont pas les examens clés (TDM oreille moyenne ++)**

□ Vu : Jan2017 Q5, Jan2017 Q10, Jan2018 Q1, Jan2018 Q4, Jan2018 Q6, Jan2020 Q1, Jan2020 Q3 ... (+23) (30×)

Otite séro-muqueuse (OSM)

- Tympan mat, niveau / bulles derrière un tympan INTACT, surdité de TRANSMISSION, tympanogramme plat
- OSM UNILATÉRALE chez l'ADULTE → rechercher en PREMIER un CANCER DU CAVUM (rhinocavoscopie obligatoire)
- OSM chez l'enfant → végétations adénoïdes
- **⚠ l'OSM ne donne PAS de surdité de perception**
- **⚠ ne pas banaliser une OSM unilatérale de l'adulte : c'est un cancer du cavum jusqu'à preuve du contraire**

□ Vu : Jan2017 Q3, Jan2017 Q4, Jan2018 Q1, Jan2018 Q4, Jan2020 Q1, Jan2020 Q8, Jan2021 Q1 ... (+19) (26×)

Otite moyenne aiguë (OMA)

- OMA collectée = otalgie + tympan BOMBÉ ± fièvre / otorrhée
- Paracentèse si : OMA hyperalgique, compliquée, fièvre persistante, nourrisson < 3 mois
- Récidives favorisées par : RGO, tabagisme passif, végétations, crèche, carence martiale
- **⚠ une tuméfaction inflammatoire RÉTRO-auriculaire (décollement du pavillon) signe une MASTOÏDITE, pas une OMA simple**
- **⚠ le coton-tige n'est pas un facteur de récurrence d'OMA**

□ Vu : Jan2017 Q1, Jan2017 Q10, Jan2018 Q1, Jan2018 Q4, Jan2018 Q5, Jan2018 Q13, Jan2020 Q1 ... (+35) (42×)

Otite moyenne chronique (OMC) — cholestéatomateuse vs simple

- OMC CHOLESTÉATOMATEUSE : otorrhée FÉTIDE tenace + perforation MARGINALE + débris épidermiques / masse blanchâtre — dangereuse
- OMC SIMPLE : perforation NON marginale (centrale), tympanosclérose, lyse ossiculaire, perforation séquellaire
- **⚠ une perforation centrale + tympanosclérose = OMC SIMPLE, pas cholestéatome**
- **⚠ l'otite tuberculeuse donne une otorrhée traînante SANS cholestéatome + perforations multiples / tympan nécrotique**

□ Vu : Jan2017 Q1, Jan2017 Q2, Jan2017 Q10, Jan2018 Q7, Jan2020 Q4, Jan2021 Q1, Jan2021 Q2 ... (+18) (25×)

[RANG 4] CANCERS ORL (LARYNX · CAVUM · VADS)

ORL • ~4.00 Q/examen • 56 Q sur 14 sessions

Cancer du LARYNX

- Signe d'appel ++ = DYSPHONIE chronique (± dyspnée, dysphagie, ADP) chez un sujet alcool-tabagique
- Mobilité des cordes vocales → laryngoscopie INDIRECTE / nasofibroscopie (patient éveillé)
- Biopsie + bilan d'extension → laryngoscopie DIRECTE (sous AG) ; panendoscopie des VADS pour tumeurs synchrones
- **⚠ l'hématémèse n'est PAS un signe d'appel de cancer laryngé**
- **⚠ la laryngoscopie directe (AG) n'évalue PAS la mobilité cordale (cordes immobilisées par la curarisation)**

□ Vu : Jan2017 Q17, Jan2017 Q18, Jan2018 Q14, Jan2020 Q13, Jan2020 Q14, Jan2021 Q9, Jan2021 Q12 ... (+23) (30×)

Laryngectomie — totale vs partielle

- Laryngectomie TOTALE = traitement de choix des T4 : curage ganglionnaire, trachéostomie DÉFINITIVE, perte de la voix laryngée, alimentation orale reprise après cicatrisation
- Contre-indications à la chirurgie PARTIELLE : mauvais état respiratoire, aryénoïdes fixés, extension sous-glottique, extension pré-épiglottique massive
- **⚠ la commissure antérieure n'est pas en soi une contre-indication à la laryngectomie partielle**

- **⚠ après laryngectomie totale la respiration se fait par le trachéostome, pas par les voies naturelles**

□ Vu : Jan2017 Q18, Jan2018 Q14, Jan2020 Q14, Jan2021 Q13, Jan2021 Q14, Jan2022 Q14, Juin2023 Q31 ... (+4) (11×)

Cancer du CAVUM (UCNT)

- 4 syndromes : otologique + rhinologique + neurologique + ganglionnaire
- ADP cervicale haute/postérieure, épistaxis récidivante, obstruction nasale unilatérale, atteinte des nerfs crâniens (diplopie/VI)
- Virus associé = EBV ; tumeur très lymphophile ; traitement = RADIO-CHIMIOthérapie (non chirurgical)
- **⚠ la DYSPHAGIE n'est PAS un signe du cancer du cavum (piège fréquent)**
- **⚠ le cavum ne se traite pas chirurgicalement en première intention**

□ Vu : Jan2017 Q19, Jan2017 Q20, Jan2018 Q15, Jan2020 Q15, Jan2021 Q11, Juin2023 Q29, Jan2024 Q11 ... (+4) (11×)

Adénopathie / masse cervicale et examen clé

- Masse latéro-cervicale dure + alcool-tabac + otalgie/dysphonie → 1^{er} examen = NASOFIBROSCOPIE (recherche du primitif)
- Ulcération buccale maligne : induration, bords irréguliers surélevés, ADP dure/fixe, saignement au contact → examen CLÉ = BIOPSIE (anatomopathologie)
- Masse médiane sous-hyoïdienne mobile à la protraction de la langue = KYSTE DU TRACTUS THYRÉOGLOSSE
- **⚠ ne JAMAIS biopsier / exérer le ganglion en premier devant une ADP cervicale suspecte (nasofibroscopie d'abord)**

□ Vu : Jan2018 Q16, Jan2020 Q19, Jan2022 Q15, Jan2023 Q10, Jan2023 Q15, Juin2023 Q37, Jan2024 Q9 ... (+6) (13×)

[RANG 5] PARALYSIE FACIALE PÉRIPHÉRIQUE

ORL • ~3.57 Q/examen • 50 Q sur 14 sessions

Orientation étiologique de la PFP

- Vésicules dans la conque / zona → PFP ZOSTÉRIENNE (syndrome de Ramsay-Hunt, VZV)
- Début brutal + otoscopie normale + sans surdité ni vertige → PFP IDIOPATHIQUE (a frigore, dx d'élimination, évolution souvent favorable, peut être complète)
- Installation progressive + surdité de perception RÉTRO-cochléaire + vertige → NEURINOME de l'acoustique
- **⚠ la PFP a frigore ne comporte ni vésicules, ni vertige, ni surdité de perception, ni trouble sensitif de la face**
- **⚠ une PFP PÉRIPHÉRIQUE atteint les territoires SUPÉRIEUR + inférieur ; une atteinte CENTRALE épargne le front (territoire supérieur)**

□ Vu : Jan2017 Q8, Jan2017 Q9, Jan2018 Q2, Jan2018 Q3, Jan2018 Q10, Jan2018 Q11, Jan2018 Q12 ... (+43) (50×)

Tests TOPOGRAPHIQUES vs tests de GRAVITÉ

- Tests TOPOGRAPHIQUES (localisation) = réflexe stapédien + test de Schirmer + électrogustométrie
- Tests de GRAVITÉ (pronostic) = testing musculaire + EMG + ÉlectroNeuronoGraphie (ENoG)
- **⚠ ne pas confondre : Schirmer/stapédien/gustométrie LOCALISENT, ils n'évaluent pas la gravité**
- **⚠ certaines clés officielles mélangent topographie et gravité — la gravité repose sur testing + EMG + ENoG**

□ Vu : Jan2017 Q8, Jan2017 Q9, Jan2018 Q3, Jan2018 Q10, Jan2018 Q12, Jan2020 Q5, Jan2020 Q10 ... (+21) (28×)

Localisation lésionnelle sur le trajet du VII

- Schirmer abaissé (larmoiement aboli) → atteinte LABYRINTHIQUE / proximale (au niveau ou au-dessus du ganglion géniculé)
- Réflexe stapédien aboli + goût altéré mais Schirmer NORMAL → portion TYMPANIQUE
- Réflexe stapédien PRÉSENT + goût altéré → portion MASTOÏDIENNE (basse)
- **⚠ une fracture du rocher passant par le ganglion géniculé abolit le réflexe stapédien**

□ Vu : Jan2018 Q10, Jan2018 Q12, Jan2021 Q7, Jan2022 Q8, Jan2023 Q5, Juin2023 Q25, Jan2024 Q7 ... (+6) (13×)

[RANG 6] GLAUCOMES

Ophtalmologie • ~3.36 Q/examen • 47 Q sur 14 sessions

□ Excavation glaucomateuse : règle ISNT (Inf > Sup > Nasal > Temporal)

Glaucome chronique à angle ouvert (GCAO)

- Obstacle TRABÉCULAIRE à l'écoulement ; cécité IRRÉVERSIBLE (atteinte du nerf optique)
- Diagnostic : HTO + champ visuel + excavation papillaire (règle ISNT) + angle OUVERT à la gonioscopie ; souvent asymétrique, héréditaire
- Traitement MÉDICAL en 1^{er} (collyres hypotonisants) ± laser SLT ± trabéculéctomie ; surveillance = TO + champ visuel
- ⚠ la cécité du GCAO n'est PAS réversible
- ⚠ pas de myosis dans la prise en charge du GCAO (≠ crise aiguë)

□ Vu : Jan2017 Q26, Jan2018 Q29, Jan2018 Q30, Jan2020 Q41, Jan2021 Q41, Jan2022 Q40, Jan2024 Q25 ... (+7) (14×)

Glaucome aigu par fermeture de l'angle (GFA)

- BLOCAGE PUPILLAIRE = primum movens → fermeture de l'angle → HTO majeure brutale
- SEMI-MYDRIASE aréflexique, cercle périkératique, œdème de cornée, chambre antérieure étroite, douleur + BAV brutales, œil rouge
- Traitement de la CRISE : hospitalisation + acétazolamide + mannitol + myotiques (pilocarpine) + antiglaucomateux ; traitement DÉFINITIF/préventif = IRIDOTOMIE laser des DEUX yeux
- ⚠ le GFA donne une SEMI-MYDRIASE, PAS un myosis (piège majeur)
- ⚠ JAMAIS de mydriatiques / atropine dans un GFA
- ⚠ facteurs de risque = HYPERMÉTROPIE + mydriase + stress — PAS le diabète ni l'HTA ; ne survient pas sur un œil parfaitement sain (angle étroit préexistant)

□ Vu : Jan2017 Q25, Jan2018 Q30, Juin2023 Q8, Juin2023 Q12, Jan2024 Q26, Juin2024 Q2, Juin2024 Q3 ... (+14) (21×)

Glaucome congénital

- Anomalie de l'angle irido-cornéen ; URGENCE CHIRURGICALE
- Buphtalmie (gros œil) + larmoiement + photophobie, souvent bilatéral ; mesure du TO sous anesthésie générale ; risque d'amblyopie
- ⚠ pas d'énophtalmie (au contraire : buphtalmie)
- ⚠ le traitement n'est pas médical : il est chirurgical

□ Vu : Jan2017 Q23, Jan2021 Q42, Jan2022 Q39, Jan2023 Q30, Jan2024 Q25 (5×)

Médicaments antiglaucomateux

- Familles : prostaglandines + bêta-bloquants + alpha-2-AGONISTES + inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (± myotiques)
- ⚠ ne font PAS partie des antiglaucomateux : antimitotiques, alpha-BLOQUANTS, inhibiteurs calciques, IPP

□ Vu : Jan2018 Q31, Jan2022 Q44, Juin2023 Q9, Jan2024 Q26, Jan2024 Q27, Juin2024 Q3, Oct2024 Q21 ... (+3) (10×)

[RANG 7] CAT : ADÉNOPATHIE CERVICALE & NODULE THYROÏDIEN

ORL • ~3.21 Q/examen • 45 Q sur 14 sessions

□ Nodule thyroïdien : EU-TIRADS + cytologie de Bethesda

Nodule thyroïdien — bilan de 1^{re} intention

- 1^{re} intention = TSH + ÉCHOGRAPHIE thyroïdienne (EU-TIRADS)
- Cytoponction conditionnée par la TAILLE + le score EU-TIRADS (ex. TIRADS 4 → cytoponction ; < 1 cm même TIRADS 5 → surveillance)

- Cytologie de Bethesda : II → surveillance ; IV → chirurgie ; malignité CONFIRMÉE par l'anatomopathologie seule
- ⚠ T3/T4, scintigraphie, calcitonine ne sont PAS systématiques d'emblée
- ⚠ la cytoponction n'est PAS systématique pour tout nodule
- ⚠ le SEXE féminin n'est pas un signe de gravité ; le carcinome MÉDULLAIRE ne fixe PAS l'iode radioactif (traitement chirurgie ± chimio/RT)

□ Vu : Jan2017 Q6, Jan2017 Q7, Jan2018 Q9, Jan2018 Q21, Jan2020 Q12, Jan2020 Q16, Jan2021 Q15 ... (+38) (45×)

Adénopathie cervicale — démarche

- ADP chronique → imagerie cervicale + thoracique + NFS + VS/CRP
- ADP métastatique → recherche du primitif + PANENDOSCOPIE des VADS (le primitif peut rester inconnu)
- ADP sus-claviculaire GAUCHE (Troisier) → origine pulmonaire / digestive / hémopathie / TB
- Masse cervicale chronique + alcool-tabac + dysphonie → ADP métastatique d'un CANCER DU LARYNX
- ⚠ la cervicotomie / biopsie ganglionnaire n'est JAMAIS le 1^{er} geste
- ⚠ les sérologies ne sont pas systématiques devant toute ADP

□ Vu : Jan2017 Q7, Jan2018 Q21, Jan2020 Q16, Jan2021 Q18, Jan2023 Q16, Jan2023 Q17, Juin2023 Q35 ... (+13) (20×)

[RANG 8] CANCÉROLOGIE MAXILLO-FACIALE

Chir. maxillo-faciale • ~3.21 Q/examen • 45 Q sur 14 sessions

Tumeurs MALIGNES des maxillaires / mandibule

- Évolution RAPIDE, signe de VINCENT (hypoesthésie V3 mandibulaire / V2 maxillaire), mobilités dentaires, révélation par une complication ou perte dentaire spontanée
- Champ histologique LARGE (odontogènes ET non odontogènes) ; extension possible (maxillaire → exophtalmie) ; fatales si non traitées
- ⚠ « jamais de curage ganglionnaire » est FAUX
- ⚠ « évolution lente » est FAUX pour les tumeurs malignes

□ Vu : Jan2018 Q50, Jan2021 Q28, Jan2022 Q26, Jan2022 Q27, Juin2023 Q47, Jan2024 Q46, Juin2024 Q34 ... (+5) (12×)

Critères radiologiques bénin / malin

- BÉNIGNITÉ : soufflure des corticales + refoulement du nerf alvéolaire inférieur (NAI) + rhizalyse (lyse des racines)
- MALIGNITÉ : RUPTURE des corticales + image de « DENTS FLOTTANTES » (lyse osseuse avec racines intègres)
- ⚠ des dents flottantes (os détruit, racines intactes) orientent vers la malignité, pas la bénignité

□ Vu : Jan2017 Q37, Jan2018 Q49, Jan2020 Q28, Jan2021 Q26, Jan2023 Q50, Nx2025 Q2, Nx2025 Q4 (7×)

Tumeurs des glandes salivaires & cavité buccale

- Adénome PLÉOMORPHE (tumeur mixte) = tumeur parotidienne la PLUS FRÉQUENTE : FERME, INDOLORE, sans PF, sans ADP
- Cancer de la cavité buccale = carcinome ÉPIDERMOÏDE ; biopsie = clé, scanner = os, IRM = parties molles, panendoscopie = 2^e localisation
- ⚠ PF + douleur + ADP devant une tumeur parotidienne orientent vers la MALIGNITÉ (pas l'adénome pléomorphe)
- ⚠ l'imagerie ne remplace pas la biopsie pour le diagnostic de cancer buccal

□ Vu : Jan2017 Q46, Jan2017 Q49, Jan2018 Q44, Jan2021 Q31, Jan2022 Q32, Jan2023 Q46, Juin2023 Q49 ... (+6) (13×)

[RANG 9] INFECTIONS RHINO-PHARYNGO-LARYNGÉES

ORL • ~3.07 Q/examen • 43 Q sur 14 sessions

Angines

- MNI : angine érythémato-pultacée + ASTHÉNIE + RASH + SPLÉNOMÉGALIE (EBV, syndrome mononucléotique)
- Angine UNILATÉRALE ulcéreuse → angine de VINCENT (fuso-spirillaire)
- ⚠ « NFS normale » dans la MNI est FAUX (lymphocytose avec lymphocytes atypiques)

□ Vu : Jan2017 Q16, Jan2018 Q8, Jan2020 Q11, Jan2022 Q7, Jan2023 Q4, Juin2023 Q24, Jan2024 Q8 ... (+6) (13×)

Rhinosinusite maxillaire aiguë

- Souvent VIRALE, guérison spontanée fréquente ; diagnostic CLINIQUE ; douleur exacerbée par l'ANTÉFLEXION
- Critères d'origine BACTÉRIENNE : douleur infra-orbitaire unilatérale persistante/croissante + rhinorrhée de plus en plus purulente
- Sinusite récidivante/unilatérale → rechercher une origine DENTAIRE (prémolaires/molaires, cacosmie)
- ⚠ TDM, prélèvement bactériologique et antibiotiques ne sont PAS systématiques
- ⚠ sinusite « bloquée » = compliquée : accentuation des douleurs + DISPARITION de la rhinorrhée (risque abcès cérébral)

□ Vu : Jan2017 Q11, Jan2017 Q12, Jan2018 Q18, Jan2021 Q10, Jan2023 Q11, Jan2023 Q13, Juin2023 Q28 ... (+8) (15×)

Pathologies de l'enfant

- Ethmoïdite aiguë = complication de rhinopharyngite : fièvre élevée + œdème sous-orbitaire (risque orbitaire) — ne guérit PAS spontanément
- Rhinopharyngite = maladie d'ADAPTATION, virale, guérison spontanée ; complications : OMA, abcès rétropharyngé, ethmoïdite, torticolis de Grisel
- ⚠ les BACTÉRIES ne sont pas les principaux agents de la rhinopharyngite ; antibiotiques non systématiques

□ Vu : Jan2017 Q13, Jan2018 Q20, Jan2022 Q17, Jan2023 Q14, Jan2024 Q13, Juin2024 Q49, Oct2024 Q45 ... (+2) (9×)

Rhinite allergique

- Hypersensibilité de TYPE I (IgE) ; associée à l'asthme ; terrain familial ; classification ARIA (durée + retentissement)
- Diagnostic = interrogatoire + tests cutanés (prick-test + si papule > 3 mm) ; traitement minimal = antihistaminiques
- ⚠ la sensibilisation allergénique initiale est ASYMPTOMATIQUE (les symptômes apparaissent au ré-contact)

□ Vu : Jan2017 Q14, Jan2017 Q15, Jan2018 Q19, Jan2020 Q17, Jan2020 Q18, Jan2021 Q8 (6×)

[RANG 10] ŒIL ROUGE

Ophtalmologie • ~3.07 Q/examen • 43 Q sur 14 sessions

Cadre nosologique de l'œil rouge

- Rouge NON douloureux SANS BAV → conjonctivite / hémorragie sous-conjonctivale / épisclérite
- Rouge DOULOUREUX SANS BAV → sclérite
- Rouge DOULOUREUX AVEC BAV → URGENCES : GFA + uvéite antérieure + kératite/ulcère herpétique
- ⚠ un œil rouge douloureux AVEC baisse de vision n'est jamais banal : éliminer GFA, uvéite, kératite

□ Vu : Jan2017 Q28, Jan2017 Q29, Jan2018 Q25, Jan2020 Q35, Jan2020 Q39, Jan2021 Q33, Jan2021 Q35 ... (+36) (43×)

Conjonctivites

- Allergique : prurit + chémosis, mastocytes/histamine → ANTIHISTAMINIQUES (forme giganto-papillaire = porteurs de lentilles)
- Virale : très contagieuse, ADP PRÉTRAGIENNE ; Bactérienne : sécrétions purulentes → ANTIBIOTIQUES collyre + lavage
- ⚠ pas de corticoïdes dans une conjonctivite virale ou bactérienne non étiquetée

□ Vu : Jan2017 Q28, Jan2021 Q40, Jan2022 Q42, Jan2022 Q45, Jan2023 Q22, Jan2024 Q28, Jan2024 Q29 ... (+4) (11×)

Épisclérite vs sclérite

- ÉPISCLÉRITE : rougeur localisée, bénigne, qui BLANCHIT à la néosynéprine (test +)
- SCLÉRITE : douleur profonde, ne blanchit PAS à la néosynéprine, impose un bilan ÉTIOLOGIQUE général
- ⚠ *confondre les deux fait manquer une maladie de système derrière une sclérite*

□ Vu : Jan2023 Q22, Juin2023 Q1, Jan2024 Q19, Juin2024 Q1, Oct2024 Q14, Nov2024 Q1, Nx2025 Q16 ... (+2) (9×)

Kératite / ulcère herpétique

- Ulcère DENDRITIQUE (test à la FLUORESCÉINE) + HYPOesthésie cornéenne = HERPÈS (HSV) → ANTIVIRAUX
- Forme PSEUDO-dendritique chez un porteur de LENTILLES → amibiase (Acanthamoeba) → anti-amibiens
- ⚠ *les CORTICOÏDES sont CONTRE-INDIQUÉS dans la kératite herpétique (risque de PERFORATION) — piège critique*

□ Vu : Jan2017 Q29, Jan2018 Q25, Jan2020 Q39, Jan2021 Q33, Jan2021 Q40, Jan2023 Q21, Juin2023 Q1 ... (+14) (21×)

[RANG 11] CELLULITES CERVICO-FACIALES D'ORIGINE DENTAIRE

Chir. maxillo-faciale • ~2.86 Q/examen • 40 Q sur 14 sessions

Cellulite cervico-faciale d'origine dentaire — principes

- Infection POLYMICROBIENNE (anaérobies +++) d'origine dentaire
- Expression : comblement vestibulaire + trismus + ADP sous-maxillaire + pus au collet dentaire ± dyspnée
- Traitement précoce → bon pronostic ; drainage chirurgical SI collectée/abcédée
- ⚠ *les AINS sont PROSCRITS (contre-indiqués) — favorisent l'extension (piège le plus répété)*
- ⚠ *l'ÉPISTAXIS n'est pas un signe de cellulite (faux fréquent)*
- ⚠ *le drainage n'est pas « toujours » indiqué : seulement si collection*

□ Vu : Jan2017 Q36, Jan2017 Q42, Jan2017 Q50, Jan2018 Q39, Jan2018 Q45, Jan2018 Q48, Jan2020 Q27 ... (+33) (40×)

Gravité et complications

- 3 signes de GRAVITÉ = gêne RESPIRATOIRE + à la DÉGLUTITION + à l'ÉLOCUTION
- Complications : thrombophlébite du sinus CAVERNEUX + MÉDIASTINITE (diffusion postérieure) — pronostic vital engagé
- ⚠ *une cellulite diffuse n'est jamais bénigne : risque de médiastinite mortelle*

□ Vu : Jan2017 Q36, Jan2018 Q48, Jan2020 Q30, Jan2022 Q29, Jan2023 Q48, Jan2023 Q49, Juin2023 Q45 ... (+7) (14×)

Lithiases salivaires (accidents)

- Accidents MÉCANIQUES = hernie salivaire + colique salivaire (liés au repas)
- Accidents INFECTIEUX = whartonite + sténonite + sous-maxillite (sous-mandibulite) aiguë
- ⚠ *l'articulé dentaire désigne la relation OCCLUSALE maxillo-mandibulaire (à ne pas confondre avec les accidents lithiasiques)*

□ Vu : Jan2017 Q50, Jan2018 Q45, Jan2020 Q32, Jan2021 Q32, Jan2022 Q33, Jan2023 Q47, Juin2023 Q50 ... (+6) (13×)

[RANG 12] CATARACTES

Ophtalmologie • ~1.86 Q/examen • 26 Q sur 14 sessions

Bilan pré-opératoire & calcul de l'implant

- Calcul de l'implant (IOL) = kératométrie + LONGUEUR AXIALE + constante A
- ⚠ *ni l'épaisseur cornéenne ni l'épaisseur du cristallin n'entrent dans le calcul de l'implant*

□ Vu : Jan2020 Q34, Nx2026 Q21 (2×)

Formes cliniques typiques

- Cataracte DIABÉTIQUE : précoce, sous-capsulaire postérieure, aspect « tempête de neige », parfois totale
- Cataracte sous-capsulaire postérieure → BAV de PRÈS prédominante (diabète, corticoïdes, post-contusion)
- Cataracte NUCLÉAIRE → diplopie MONOCULAIRE + myopie d'indice (longueur axiale normale)
- *⚠ une diplopie MONOCULAIRE oriente vers une cataracte, PAS vers une paralysie oculomotrice (qui donne une diplopie binoculaire)*

□ Vu : Jan2017 Q22, Jan2018 Q23, Jan2018 Q26, Jan2018 Q27, Jan2020 Q33, Jan2020 Q34, Jan2020 Q36 ... (+19) (26×)

Cataracte congénitale

- URGENCE (risque d'amblyopie) ; rechercher embryofœtopathie / TORCH (rubéole) ; traitement chirurgical + rééducation ; peut être héréditaire, associée au glaucome congénital
- Leucocorie → évoquer rétinoblastome / cataracte congénitale / persistance du vitré primitif
- *⚠ la cataracte congénitale n'est pas « purement médicale » et ne s'opère pas « après 5 ans » : prise en charge précoce*

□ Vu : Jan2017 Q22, Jan2018 Q23, Jan2018 Q26, Jan2018 Q27, Jan2020 Q42, Jan2022 Q36, Jan2023 Q20 ... (+1) (8×)

Complications de la chirurgie

- Cataracte SECONDAIRE = opacification de la capsule postérieure après chirurgie (traitement : capsulotomie YAG)
- ENDOPHTALMIE = complication la plus grave : prophylaxie par bétadine + céfuroxime intracaméculaire ; traitement = IVT antibiotiques
- *⚠ la « cataracte secondaire » n'est pas une récurrence du cristallin (déjà retiré) mais une opacification capsulaire*

□ Vu : Jan2020 Q37, Jan2020 Q38, Jan2020 Q40, Jan2021 Q37, Jan2021 Q38, Jan2022 Q35, Ratt2025 Q48 (7×)

[RANG 13] LIMITATION DE L'OUVERTURE BUCCALE

Chir. maxillo-faciale • ~1.79 Q/examen • 25 Q sur 14 sessions

Blocage maxillo-mandibulaire (BMM) — indication

- Le BMM est indiqué dans le traitement d'une fracture MANDIBULAIRE
- *⚠ le BMM ne traite PAS les fractures du malaire, du plancher de l'orbite, des os propres du nez, ni de l'arcade zygomatique*

□ Vu : Nx2025 Q10, Ratt2025 Q25 (2×)

Constriction des mâchoires — TRANSITOIRE vs PERMANENTE

- Constriction TRANSITOIRE (réversible) = TÉTANOS (trismus) +++
- Constriction PERMANENTE (organique, fixée) = ankylose temporo-mandibulaire + maladie de Langenbeck + sclérose des parties molles POST-RADIQUE + hématome CALCIFIÉ du muscle temporal
- *⚠ classer le tétanos en constriction PERMANENTE est FAUX (il est transitoire)*
- *⚠ classer l'ankylose / Langenbeck / sclérose post-radique / hématome calcifié en TRANSITOIRE est FAUX (ce sont des causes permanentes)*
- *⚠ nuance : l'ankylose est intra-articulaire, la « constriction permanente » classique est extra-articulaire — mais la clé officielle regroupe l'ankylose avec les causes permanentes*

□ Vu : Jan2017 Q47, Jan2018 Q42, Jan2021 Q29, Jan2022 Q30, Jan2023 Q45, Juin2023 Q48, Jan2024 Q47 ... (+5) (12×)

Ankylose temporo-mandibulaire BILATÉRALE de l'enfant

- SOUVENT secondaire à une fracture SOUS-CONDYLIENNE ; entraîne une micro-rétrognathie SYMÉTRIQUE (car bilatérale)
- RETENTIT sur l'hygiène bucco-dentaire ; diagnostic positif RADIO-CLINIQUE (clinique + imagerie)
- *⚠ « évolue spontanément vers la guérison » est FAUX (traitement chirurgical nécessaire)*
- *⚠ « micro-rétrognathie ASYMÉTRIQUE » est FAUX pour une forme bilatérale (l'asymétrie = atteinte unilatérale)*

- **⚠ « diagnostic clinique » seul est FAUX (il est radio-CLINIQUE) ; « ne retentit pas sur l'hygiène » est FAUX**

□ Vu : Jan2017 Q47, Jan2017 Q48, Jan2018 Q42, Jan2018 Q43, Jan2020 Q31, Jan2021 Q29, Jan2021 Q30 ... (+16) (23×)

[RANG 14] RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE

Ophtalmologie • ~1.64 Q/examen • 23 Q sur 14 sessions

□ RD : classification ALFEDIAM / proliférante vs non proliférante

Physiopathologie & dépistage

- MICRO-angiopathie secondaire à l'hyperglycémie chronique (perte des péricytes, atteinte de la paroi vasculaire)
- 1^{er} signe ophtalmoscopique = MICRO-ANÉVRISME ; rechercher une NÉPHROPATHIE associée
- Surveillance = fond d'œil + angiographie à la fluorescéine (+ OCT pour l'œdème maculaire)
- **⚠ ce n'est PAS une macro-angiopathie ; le 1^{er} signe n'est ni l'hémorragie ni les exsudats mais le micro-anévrisme**

□ Vu : Jan2017 Q27, Jan2018 Q22, Jan2020 Q43, Jan2021 Q43, Jan2022 Q37, Jan2022 Q38, Jan2023 Q25 ... (+16) (23×)

Classification & traitement

- Classification fondée sur la NÉOVASCULARISATION (proliférante vs non proliférante) + examen ophtalmoscopique
- RD non proliférante = micro-anévrismes + exsudats (sans néovaisseaux)
- Traitement : équilibre glycémique + contrôle des FdR (HTA, néphropathie) + LASER (PPR) si indiqué + anti-VEGF / corticoïdes IVT pour l'œdème maculaire
- **⚠ la photocoagulation pan-rétinienne n'est PAS systématique d'emblée (selon le stade)**
- **⚠ BAV brutale chez un diabétique → hémorragie intra-vitréenne ou décollement (forme proliférante)**

□ Vu : Jan2017 Q27, Jan2018 Q22, Jan2020 Q43, Jan2021 Q43, Jan2022 Q38, Jan2023 Q25, Jan2023 Q26 ... (+6) (13×)

[RANG 15] GREFFE DE CORNÉE (KÉRATOPLASTIE)

Ophtalmologie • ~0.50 Q/examen • 7 Q sur 14 sessions

Kératoplastie — indications

- Indications : kératocône + taies/opacités + dystrophies + complications cornéennes de chirurgie de cataracte
- Indication la PLUS FRÉQUENTE = KÉRATOCÔNE ; greffe la plus pratiquée au monde, bons résultats fonctionnels ; rejet à prévenir
- **⚠ le kératocône (dystrophie ectasique du sujet jeune, aggravée par le frottement oculaire) est la 1^{re} indication, pas une contre-indication**

□ Vu : Jan2017 Q30, Jan2018 Q28, Jan2020 Q44, Jan2022 Q34, Jan2023 Q27, Jan2024 Q21, Nov2024 Q5 (7×)

Don de cornée (contexte marocain)

- Le don d'organes/de cornée est régi par la LOI (loi 16-98) ; banque des yeux = structure de conservation ; offre insuffisante → nécessité de promotion

□ Vu : Jan2017 Q30, Jan2020 Q44, Jan2022 Q34 (3×)

[RANG 16] RÉTINOBLASTOME

Ophtalmologie • ~0.50 Q/examen • 7 Q sur 14 sessions

Rétinoblastome

- Tumeur rétinienne MALIGNE la plus fréquente de l'ENFANT ; origine GÉNÉTIQUE (forme bilatérale héréditaire, gène RB1)
- Signes d'alarme = LEUCOCORIE + STRABISME ; extension par le nerf optique / la choroïde ; engage le pronostic VITAL
- Prise en charge MULTIDISCIPLINAIRE (chirurgie ± chimiothérapie) ; dépistage de la fratrie
- *⚠ le rétinoblastome n'est ni « purement chirurgical » ni « purement médical » : il est multidisciplinaire*
- *⚠ une leucocorie de l'enfant impose d'évoquer un rétinoblastome EN PREMIER*

□ Vu : Jan2017 Q21, Jan2017 Q24, Jan2018 Q24, Jan2023 Q29, Juin2023 Q4, Juin2023 Q5, Jan2024 Q22 (7×)

[RANG 17] TROUBLES DE LA RÉFRACTION

Ophtalmologie • ~0.36 Q/examen • 5 Q sur 14 sessions

Amétropies & presbytie

- HYPERMÉTROPIE : globe trop COURT (forme axile), souvent associée au strabisme convergent + céphalées, souvent latente chez l'enfant
- Myopie d'INDICE = cataracte nucléaire ; PRESBYTIE = 1^{re} cause de BAV de près après ~45 ans
- Chirurgie LASER de la myopie = photoablation cornéenne (aussi pour hypermétropie) — nécessite un bilan cornéen préalable
- *⚠ le laser ne traite pas « tous les types » sans condition et JAMAIS « sans bilan cornéen » préalable*
- *⚠ l'amblyopie (complice strabisme / cataracte congénitale / anisométrie) doit être traitée AVANT 8 ans*

□ Vu : Jan2021 Q34, Jan2021 Q36, Jan2023 Q23, Jan2023 Q24, Jan2024 Q23 (5×)

[RANG 18] QUESTIONS INCLASSIFIABLES

— • ~0.07 Q/examen • 1 Q sur 14 sessions

Item isolé (hors des grands chapitres)

- 1 seule question recensée : accidents infectieux des lithiases salivaires (whartonite / sous-maxillite / sténite) — voir RANG 11
- *⚠ ne pas en faire un chapitre à part : le fond est déjà couvert par la cellulite / lithiases salivaires (RANG 11)*

PARTIE 4 — BANQUE SUPPLÉMENTAIRE : CORRECTIONS COMMUNAUTAIRES (2026)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

Questions issues des regroupements de révision Ophtalmo — corrections COLLECTIVES (communautaires).

Corrections NON officielles — à relire à la lumière de la PARTIE 3.

À UTILISER AVEC PRUDENCE — MAIS BON À CONNAÎTRE.

Ces questions de révision représentent ~14.8% du volume total recensé (hors des 14 sessions officielles). Elles portent sur les MÊMES thèmes que les leçons officielles, mais leurs corrections étant communautaires, elles peuvent :

- Contenir des erreurs de correction (recouper chaque item avec la PARTIE 3)
- Couvrir des variantes de questions utiles à l'entraînement
- Servir de banque d'entraînement supplémentaire

Banque supplémentaire — révision Ophtalmo (corrections communautaires) :

Banque supplémentaire (corrections communautaires)	Total	Moy/exam
Révision Ophtalmo — regrouper 1 (correction collective)	50 Q	—
Révision Ophtalmo — regrouper 2 (correction collective)	72 Q	—

[SUPPL. 1] BANQUE DE RÉVISION OPHTALMO (CORRECTIONS COMMUNAUTAIRES)

122 questions supplémentaires — hors des 14 sessions officielles

- ☐ Regrouper 1 (50 Q) — correction collective : [Ouvrir le lien ↗](#)
- ☐ Regrouper 2 (72 Q) — correction collective : [Ouvrir le lien ↗](#)

Nature de cette banque

- 122 questions d'entraînement portant sur les MÊMES thèmes ophtalmo que les RANGS 1, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17
- Corrections COLLECTIVES (communautaires) : non issues des corrections officielles des 14 sessions
- ⚠ *recouper systématiquement chaque réponse avec la PARTIE 3 (les corrections communautaires peuvent contenir des erreurs)*

Repères ophtalmo à réviser en priorité (rappel haute fréquence)

- GFA = semi-mydriase + JAMAIS de mydriatiques ; GCAO = cécité irréversible, traitement médical d'abord
- Kératite herpétique = ulcère dendritique + corticoïdes CONTRE-INDIQUÉS
- Plaie du globe = hypotonie + Seidel + ; NE PAS mesurer le TO ; coque + à jeun + SAT
- Brûlure : BASE > acide ; lavage immédiat sur les lieux
- RD : 1^{er} signe = micro-anévrisme ; classification sur la néovascularisation
- Leucocorie de l'enfant → rétinoblastome jusqu'à preuve du contraire

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS ORL – OPHTALMOLOGIE – STOMATOLOGIE & CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

** CLASSIFICATIONS & RÈGLES À RETENIR **

Excavation glaucomateuse	Règle ISNT (Inf > Sup > Nasal > Temporal)
Brûlures oculaires	Roper-Hall (atteinte limbique = pronostic)
Nodule thyroïdien	EU-TIRADS + cytologie de Bethesda
Étage moyen de la face	Le Fort I (maxillaire) / II (naso-maxillaire) / III (cranio-facial)
Rétinopathie diabétique	Proliférante vs non proliférante (néovascularisation)
Constriction des mâchoires	Transitoire (tétanos) vs permanente (ankylose, post-radique...)
Embryofœtopathies	TORCH = Toxo · Rubéole · CMV · Herpès

** SIGNES-CLÉS & TESTS DISCRIMINANTS **

Marqueur / Critère	Indication
Seidel positif	Plaie cornéenne (fuite d'humeur aqueuse)
Semi-mydrise	GFA (≠ myosis de l'uvéite antérieure)
Néosynéprine : blanchit / ne blanchit pas	Épisclérite / Sclérite
Tympanogramme plat	OSM (pic + Valsalva + = otospongiose)
Schirmer / stapédien / gustométrie	TOPOGRAPHIE de la PFP (≠ gravité : testing + EMG + ENoG)
Signe de Vincent	Hypoesthésie V → tumeur maligne mandibulaire (V3) / maxillaire (V2)
Micro-anévrisme	1 ^{er} signe de la rétinopathie diabétique
Leucocorie + strabisme	Rétinoblastome de l'enfant
Dents flottantes (radio)	Malignité osseuse (racines intègres, os détruit)

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS **

- ⚠ *BASE plus grave que l'acide dans les brûlures oculaires (et non l'inverse)*
- ⚠ *Corticoïdes CONTRE-INDIQUÉS dans la kératite herpétique (risque de perforation)*
- ⚠ *AINS PROSCRITS dans la cellulite cervico-faciale d'origine dentaire*
- ⚠ *JAMAIS de mydriatiques dans le glaucome aigu par fermeture de l'angle*
- ⚠ *La DYSPHAGIE n'est PAS un signe du cancer du cavum*
- ⚠ *NASOFIBROSCOPIE avant toute biopsie ganglionnaire devant une ADP cervicale*
- ⚠ *OSM unilatérale de l'adulte = cancer du cavum jusqu'à preuve du contraire*
- ⚠ *Le carcinome médullaire de la thyroïde ne fixe PAS l'iode radioactif*
- ⚠ *Diplopie MONOCULAIRE = cataracte (la paralysie oculomotrice donne une diplopie binoculaire)*
- ⚠ *Tétanos = constriction TRANSITOIRE des mâchoires (pas permanente)*
- ⚠ *Ne pas mesurer le tonus oculaire sur un globe ouvert*

** ENCHAÎNEMENTS / CONDUITES À TENIR **

- Œil rouge douloureux + BAV → GFA / uvéite antérieure / kératite herpétique
- Plaie du globe → hospitalisation · à jeun · coque rigide · SAT · imagerie si CEIO · suture → guetter l'endophtalmie (IVT)
- Brûlure oculaire → lavage abondant immédiat sur les lieux (avant tout transfert)
- Morsure de chien jugale > 24 h → lavage + parage SANS suture
- Nodule thyroïdien → TSH + échographie → EU-TIRADS / taille → cytoponction → Bethesda → chirurgie
- ADP cervicale suspecte → nasofibroscopie → panendoscopie VADS (biopsie ganglionnaire en dernier)
- Fracture du condyle chez l'enfant → risque d'ankylose temporo-mandibulaire (micro-rétrognathie)
- OSM unilatérale de l'adulte → rhinocavoscopie (cancer du cavum)

Généré par Claude.ai (Claude (Opus 4.8)) — Version 1
Cross-match 700 QEs officielles × Cours AIO (ORL 419 p · Ophtalmo 424 p · Maxillo 330 p)
FMPM — 14 sessions officielles · Janvier 2017 → Normal 2026

Améliorations Version 1 :

- ✓ Cross-match 700 QE officielles (14 sessions, 2017→2026) × cours AIO
- ✓ PARTIE 3 strictement par rang de fréquence (1 → 18)
- ✓ Citations dérivées de la banque réelle (sessions + n° de question)
- ✓ FAUX explicites (pièges) signalés par △ ; clés officielles discutables signalées
- ✓ PARTIE 4 = banque de révision communautaire (corrections NON officielles) — disclaimer adapté